



LA SALUD DE LAS MUJERES

Bial



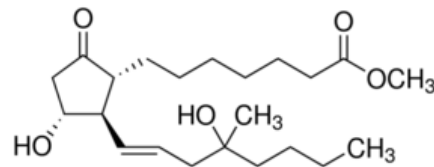
GESTIÓN DEL PARTO MISOPROSTOL 25

¿QUÉ ES MISOPROSTOL 25µg?

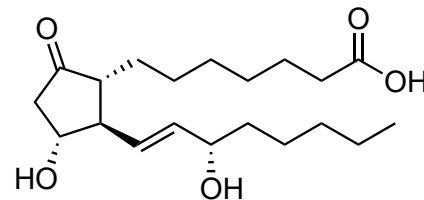
Misoprostol a la dosis de 25 µg es un análogo sintético de la PGE 1 indicado para la maduración cervical y la inducción del parto a término, en particular en casos de un cuello uterino inmaduro (agente uterotónico).

PRODUCTO HOSPITALARIO

MISOPROSTOL



PROSTAGLANDINA E1



PARTO:

MÉTODOS DE INDUCCIÓN

EN CASO DE CUELLO UTERINO FAVORABLE



Cuando el cuello uterino es favorable o está maduro, los oxitócicos se utilizan para **inducir el parto** estimulando las **contracciones uterinas**.

OXITOCINA

METHYLERGOMETRINE



CUANDO EL CUELLO UTERINO AÚN TIENE QUE MADURAR

Cuando el cuello uterino no está maduro o es desfavorable, se utilizan medicamentos que estimulan la maduración cervical inicial para **inducir el parto (prostaglandinas)**.

DINOPROSTONA

MISOPROSTOL

MISOPROSTOL

MECANISMO DE ACCIÓN



Disolución
del colágeno¹

+

Aumento de los
glicosaminoglicanos²

+

Aumento de la
sensibilidad del
miometrio a la oxitocina¹

+



Orientación de las fibras
musculares del
miometrio¹

+

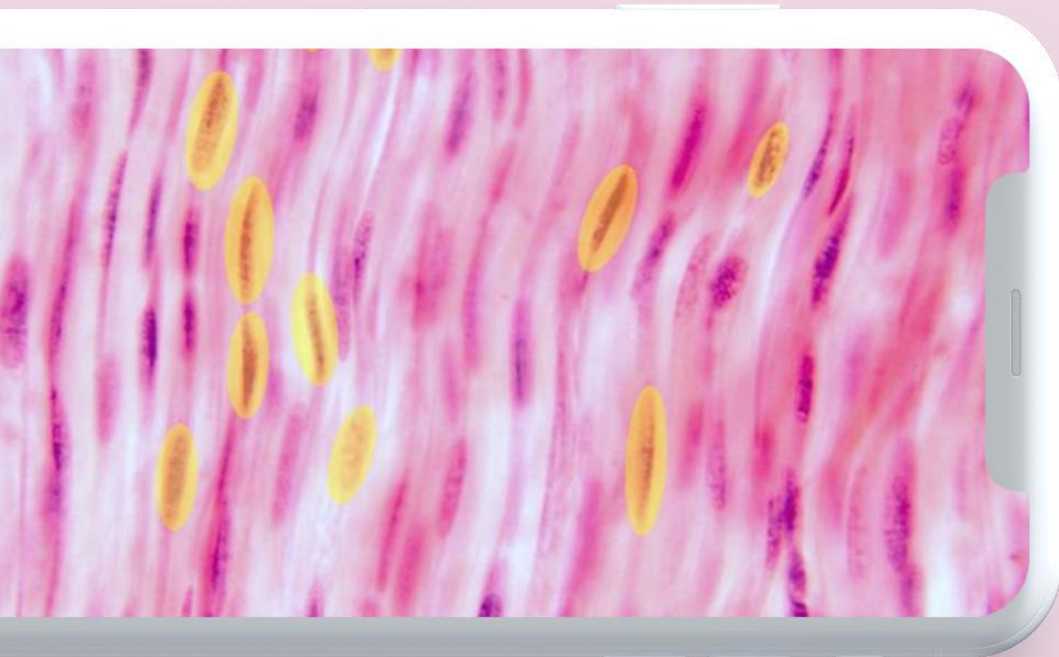
Referencias:

1: Misofar 25 SmPC, 2: Wing D, Stephenson M. A novel misoprostol delivery system for induction of labor: clinical utility and patient considerations. Drug. Des. Devel. Ther. 2015;2321-.

Bial, 2022 - For exclusive internal use : for educational, general reference and informational purposes only, within the training context. Any unauthorized use, reproduction, distribution, recording or modification of these text and images is strictly

MISOPROSTOL

MECANISMO DE ACCIÓN



Disolución del colágeno

COLÁGENO

El colágeno preserva la rigidez y la consistencia del cuello uterino durante el embarazo para mantener la cavidad uterina "cerrada" y evitar los **riesgos de parto prematuro**.¹

Misoprostol activa las **colagenasas**, enzimas que degradan las fibras de colágeno y, por lo tanto, permiten que el cuello uterino se ablande.²

Referencias:

1: Misofar 25 SmPC, 2: Wing D, Stephenson M. A novel misoprostol delivery system for induction of labor: clinical utility and patient considerations. Drug. Des. Devel. Ther. 2015;2321-.

Bial, 2022 - For exclusive internal use : for educational, general reference and informational purposes only, within the training context. Any unauthorized use, reproduction, distribution, recording or modification of these text and images is strictly

MISOPROSTOL

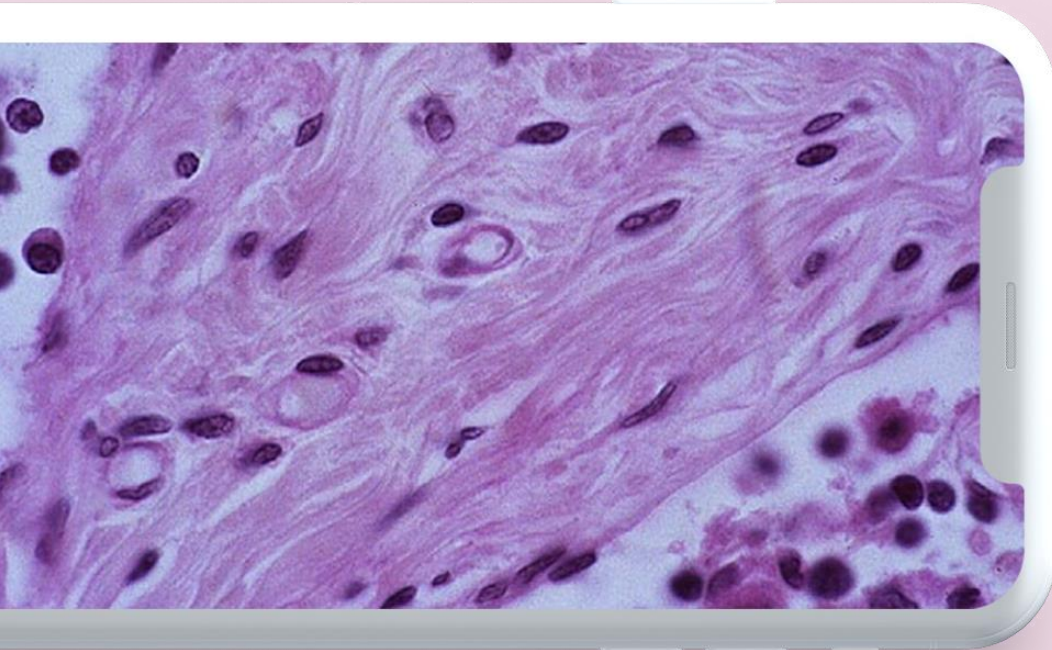
MECANISMO DE ACCIÓN

Aumento de los
glicosaminoglicanos

GLICOSAMINOGLICANOS

El sulfato de dermatán y el sulfato de condroitina se mantienen en niveles altos durante todo el embarazo, ayudando a que las fibras de colágeno se fortalezcan y promoviendo la rigidez del cuello uterino.¹

Misoprostol reduce las concentraciones de estos dos glicosaminoglicanos y aumenta las de otro glicosaminoglicano, el ácido hialurónico, que ablanda el cuello uterino y lo hincha reteniendo agua y sodio.²



Referencias:

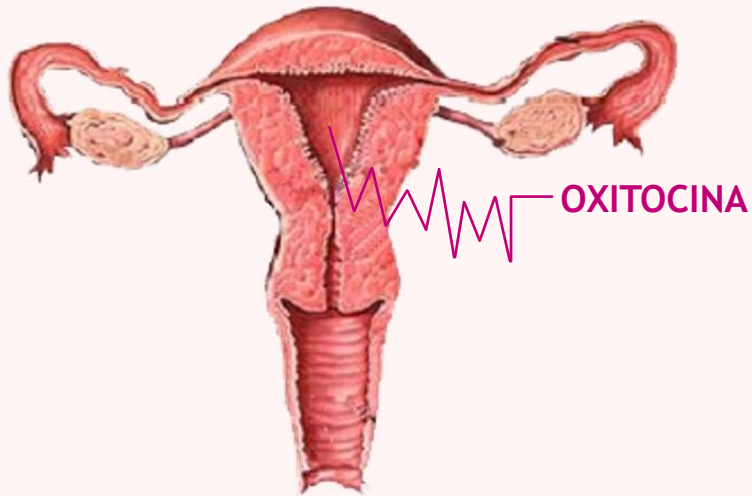
1: Misofar 25 SmPC, 2: Wing D, Stephenson M. A novel misoprostol delivery system for induction of labor: clinical utility and patient considerations. Drug. Des. Devel. Ther. 2015;2321-.

Bial, 2022 - For exclusive internal use : for educational, general reference and informational purposes only, within the training context. Any unauthorized use, reproduction, distribution, recording or modification of these text and images is strictly

MISOPROSTOL

MECANISMO DE ACCIÓN

Aumento de la sensibilidad del
miometrio a la oxitocina¹



Misoprostol favorece la sensibilidad del
miometrio a la oxitocina que actúa sobre el
útero y produce contracciones.

Referencias:

1: Wing D, Stephenson M. A novel misoprostol delivery system for induction of labor: clinical utility and patient considerations. Drug. Des. Devel. Ther. 2015;2321-.

Bial, 2022 - For exclusive internal use : for educational, general reference and informational purposes only, within the training context. Any unauthorized use, reproduction, distribution, recording or modification of these text and images is strictly

MISOPROSTOL

MECANISMO DE ACCIÓN



Orientación de las fibras musculares
en el sentido de la tensión



Se facilita el descenso de la presentación fetal

DIRECTRICES SOBRE LA INDUCCIÓN DEL PARTO



OMS

Organización
Mundial
de la Salud



La administración en dosis bajas de misoprostol (25 µg, cada 6 horas) por vía vaginal está recomendada para la **inducción del parto**.¹



FIGO

Federación
Internacional
de Ginecología y
Obstetricia



A partir de las 26 semanas de gestación, **inducción del parto** con administración de 25 µg por vía vaginal cada 6 horas.²



ACOG

Colegio
Estadounidense de
Obstetras y
Ginecólogos



Es importante tener en cuenta que la dosis inicial de misoprostol para la maduración cervical y la **inducción del parto** sea de aproximadamente 25 µg. La frecuencia de administración no debe ser superior a una vez cada 3 a 6 horas.³



EL USO DE MISOPROSTOL 25 µg INDICADO PARA INDUCIR LA MADURACIÓN CERVICAL Y PROVOCAR LA INDUCCIÓN DEL PARTO ESTÁ RECOMENDADO POR LAS PRINCIPALES DIRECTRICES. ¹⁻³





PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS

FARMACOCINÉTICA

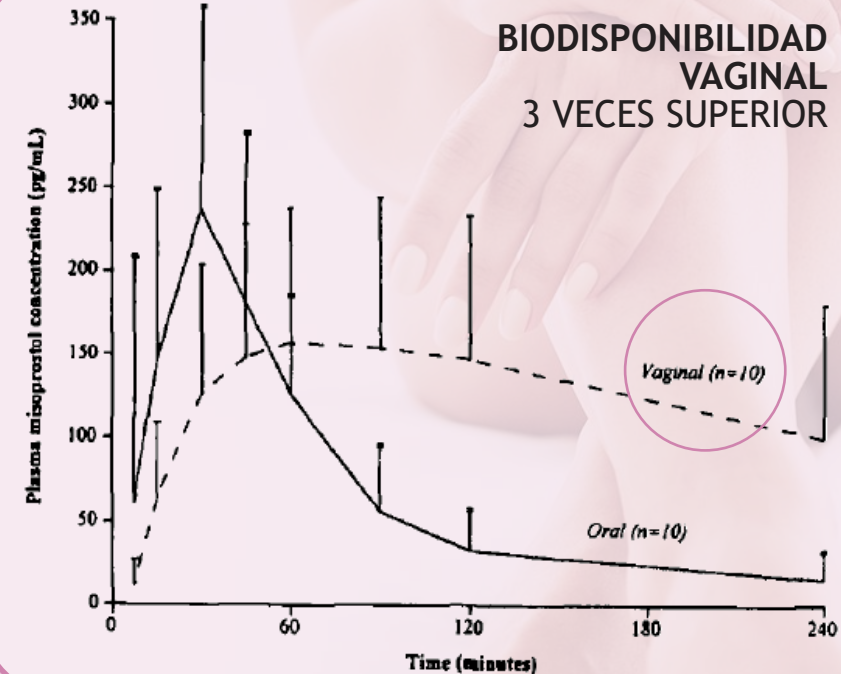
ADMINISTRACIÓN VAGINAL¹



Después de la administración vaginal, todas las pacientes presentan un aumento gradual de las concentraciones de ácido misoprostólico y los niveles más altos se alcanzan tras entre **60 y 120 minutos** (80 ± 27 min en comparación con la administración oral, $p < 0,001$), que descienden gradualmente hasta el 61 % de los niveles más altos a los 240 minutos después de la administración



Las concentraciones plasmáticas **quedan relativamente estables durante las 6 horas** posteriores a la administración.



Referencias:

1:Zieman M et al . Absorption kinetics of misoprostol with oral or vaginal administration. Obstet Gynecol 1997; 90: 82-89

Bial, 2022 - For exclusive internal use : for educational, general reference and informational purposes only, within the training context. Any unauthorized use, reproduction, distribution, recording or modification of these text and

FARMACOCINÉTICA

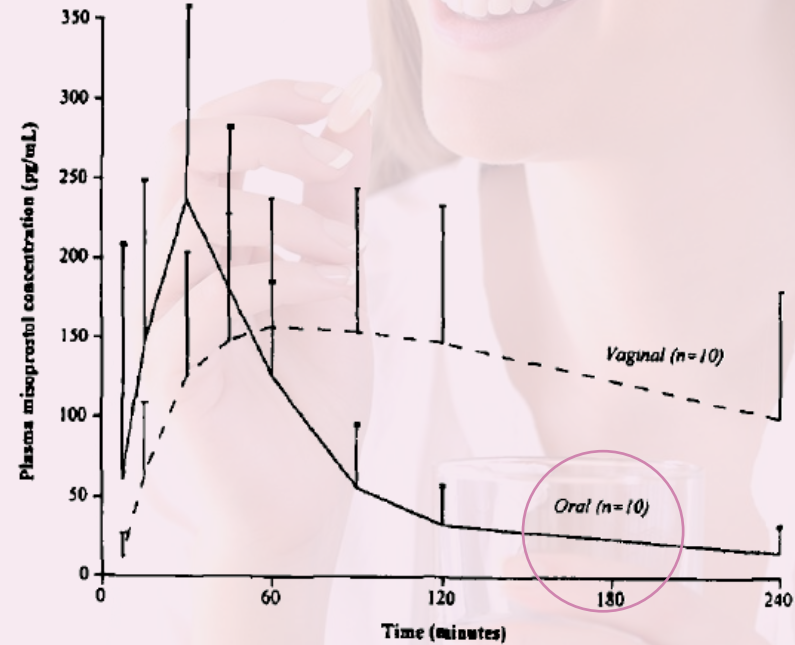
ADMINISTRACIÓN ORAL¹



Después de la administración oral, los **niveles más altos** de ácido misoprostólico se alcanzan tras entre **12,5 y 60 minutos**.



Estos valores caen después de 120 minutos y permanecen bajos.



Referencias:

1:Zieman M et al . Absorption kinetics of misoprostol with oral or vaginal administration. Obstet Gynecol 1997; 90: 82-89

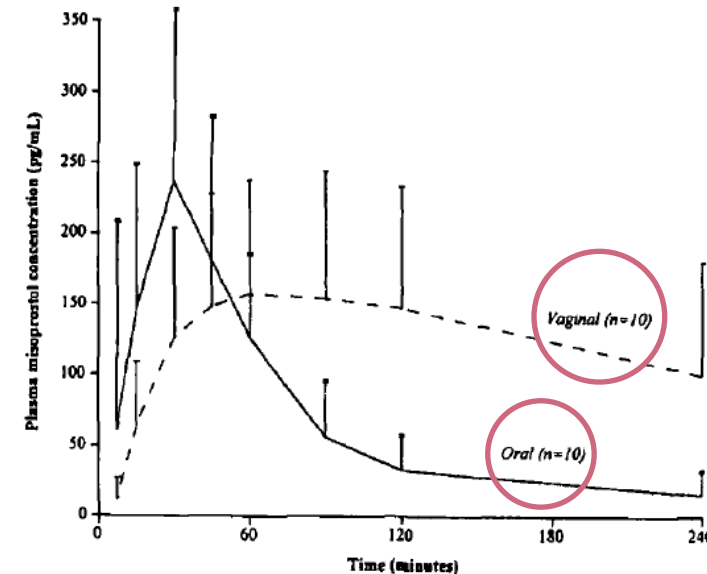
Bial, 2022 - For exclusive internal use : for educational, general reference and informational purposes only, within the training context. Any unauthorized use, reproduction, distribution, recording or modification of these text and images is strictly prohibited.

FARMACOCINÉTICA

LAS VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE MISOPROSTOL¹

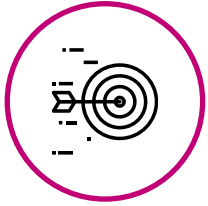
El ácido misoprostólico, el principal metabolito activo del misoprostol, se une fuertemente a las proteínas plasmáticas, con valores que rondan el **80 - 90 %**.

La unión del fármaco a las proteínas plasmáticas se produce independientemente de la concentración plasmática de misoprostol o de sus metabolitos, cuando se administra a dosis terapéuticas.



FARMACOCINÉTICA

DIFERENCIAS ENTRE LAS VÍAS DE ADMINISTRACIÓN¹



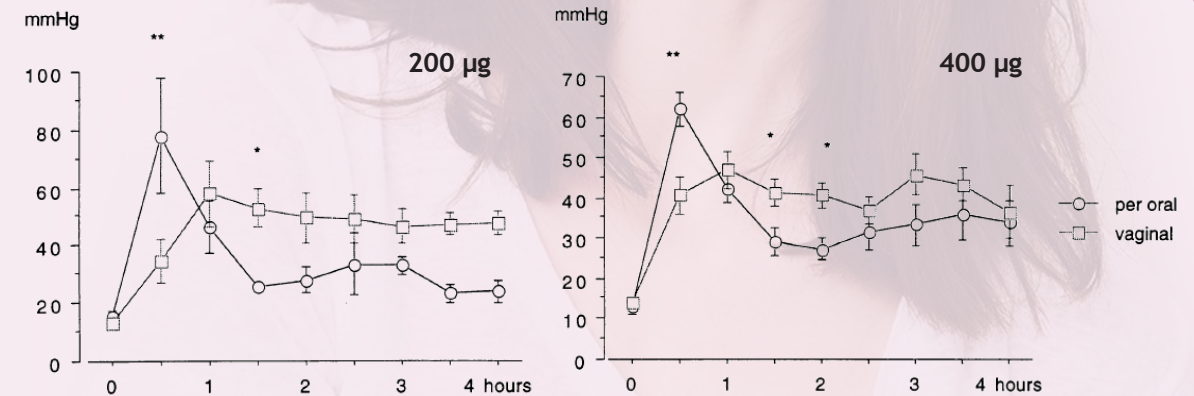
Con la administración oral, el efecto fue más rápido y el aumento inicial más pronunciado que con la administración vaginal.



Con la administración vaginal, el aumento del tono **duró más tiempo**. Las contracciones uterinas aumentaron lenta y gradualmente en todas las mujeres a las que se administró misoprostol vía vaginal.



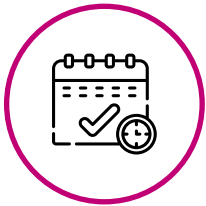
Se observó una **diferencia significativa** en la actividad uterina entre las dos vías de administración 2 horas después del tratamiento, que se hizo más evidente después de las 4 horas posteriores al inicio del tratamiento.



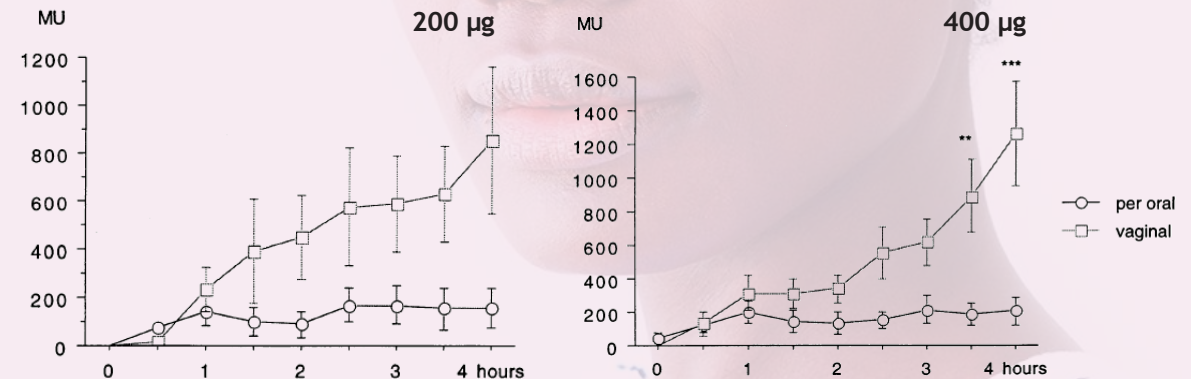
$P < 0.05$; ** $P < 0.01$; *** $P < 0.001$

FARMACOCINÉTICA

DIFERENCIAS ENTRE LAS VÍAS DE ADMINISTRACIÓN¹



Los datos clínicos demuestran que la administración vaginal de misoprostol **actúa únicamente para proporcionar una estimulación duradera de la contractilidad.**



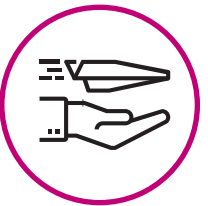
P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.001

FARMACOCINÉTICA

DIFERENCIAS ENTRE LAS VÍAS DE ADMINISTRACIÓN¹



Una de las ventajas de la vía vaginal es que **el efecto de primer paso hepático no se produce**, por lo que se evita que una parte del misoprostol sea metabolizado inmediatamente por el sistema porta.



Esta puede ser una de las razones por las que **los valores plasmáticos permanecen elevados** a los 240 minutos en comparación con las vías oral y sublingual, y por la que la disponibilidad de misoprostol es mayor.

Zieman M et al. Absorption kinetics of misoprostol with oral or vaginal administration. Obstet Gynecol 1997; 90: 82-89

Comparación de los perfiles farmacocinéticos de la administración oral y vaginal

Variable	Vaginal (n=10)	Oral (n=10)	P
Cmax (pg/mL)	165 ± 86	277 ± 124	0,03
Tmáx (min)	80 ± 27	34 ± 17	<0.001
AUC _{0-240 min}	503,3 ± 296,7	273,3 ± 110,0	0,033
AUC _{0-360 min}	956,7 ± 541,7	300,0 ± 103,3	0,029

MISOPROSTOL frente a DINOPROSTONA

		MISOPROSTOL PGE ₁	DINOPROSTONA PGE ₂
PARTO POR VÍA VAGINAL (%)	12 h	34,09	19,0
	24 h	90,90	47,61
PACIENTES QUE PRECISAN ADMINISTRACIÓN DE OXITOCINA TRAS LA INDUCCIÓN (%)		29,54	52,38
REQUIERE UNA REFRIGERACIÓN CONSTANTE		NO	SÍ
PRECIO		BAJO	ELEVADO

Adaptado de referencias 1,2,3,4,5,6,7

VENTAJAS DEL MISOPROSTOL




Mayor eficacia:
más nacimientos
por vía vaginal en las
12 a 24 horas. ^{1, 2, 5}


Intervalo más corto
entre la inducción y
el parto ¹


Menor necesidad de
oxitocina tras la
inducción. ^{1, 6, 7}


El misoprostol es
estable a temperatura
ambiente, mientras
que la dinoprostona
requiere una
refrigeración
continua ^{2-4, 6}


Precio
considerablemente
más bajo ²⁻⁷

MISOFAR 25 µg[®] ES MÁS EFICAZ Y ECONÓMICO QUE LA DINOPROSTONA,
CON UN PERFIL DE SEGURIDAD SIMILAR.⁵

1: Krithika KS, Aggarwal N, Suri V. Prospective randomised controlled trial to compare safety and efficacy of intravaginal Misoprostol with intracervical Cerviprime for induction of labour with unfavourable cervix. J. Obstet. Gynaecol. 2008;28(3):294-7. 2: W Chen, J Xue, MK Peprah, SW Wen, M Walker, Y Gao, et al. A systematic review and network meta-analysis comparing the use of Foley catheters, misoprostol, and dinoprostone for cervical ripening in the induction of labour. BJOG. 2016;123(3):346-354. 3:Tang, O. S., K. Gemzell-Danielsson, and P. C. Ho “Misoprostol: pharmacokinetic, profiles, effects on the uterus and side-effects.” International Journal of Gynecology & Obstetrics 99 (2007): S160-S167. 4: NAPOLES MENDEZ, Danilo; GOMEZ NEYRA, Yorgan y CAVEDA GIL, Ángel.Experiencia con el uso del misoprostol en la preinducción e inducción del parto. Rev Cubana Obstet Ginecol [online]. 2007, vol.33, n.3. ISSN 0138-600X. 5: Quijada Cazorla M A, Palacios Marques A M, Sanmartin J M, Amoros E C, Escoriza J C M. Effectiveness, safety and costs of labor induction with intravaginal misoprostol versus dinoprostone vaginal insert. Clin. Investig. (Lond). 2017;07(01). 6: Aquino M M A d, Cecatti J G. Misoprostol versus oxytocin for labor induction in term and post-term pregnancy: randomized controlled trial. Sao. Paulo. Med. J. 2003;121(3):102-106. 7: Sampedrano, Istria Molinero, et al. “Impacto del cambio de fármaco utilizado en la inducción del parto: misoprostol vaginal vs. Dinoprostona” Progresos de Obstetricia y ginecología: revista oficial de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 59.4 (2016): 205-210.

POSOLOGÍA



DOSIS
RECOMENDADA

25 μg

>

4-6
horas

INTERVALOS MÍNIMOS

La dosis de 25 μg puede administrarse cada 4-6 horas hasta un máximo de 4-6 administraciones.



La dosis debe ser adaptada a la respuesta de la paciente. La dosis recomendada es de 25 microgramos de misoprostol a intervalos mínimos de 4-6 horas.



ADMINISTRACIÓN

INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN Y USO

Se deben seguir las siguientes instrucciones.

1



Extraiga el comprimido vaginal de su blíster

2



La paciente debe recostarse **sobre la espalda**, con las rodillas subidas hacia el pecho

3



Utilizando la **punta del dedo medio**, el comprimido vaginal debe introducirse en la **vagina lo más profundamente posible** sin causar molestias. Es necesario lavarse bien las manos antes de introducir el comprimido.

Referencias:

1: Misofar 25 SmPC

Bial, 2022 - For exclusive internal use : for educational, general reference and informational purposes only, within the training context. Any unauthorized use, reproduction, distribution, recording or modification of these text and images is strictly

CONTRAINDICACIONES



Pacientes para las que los oxitócicos están contraindicados



Pacientes para quienes las contracciones prolongadas son inapropiadas



Antecedentes de alergia al misoprostol



Administración concomitante de oxitócicos con otros estimulantes de las contracciones uterinas (4 horas)



Pacientes con riesgo de embolia de líquido amniótico, preeclampsia grave o eclampsia



Pacientes en las que no esté indicado el parto por vía vaginal (placenta previa, VHS activo)



PACIENTES CON:

- **Antecedentes de cesárea** o cirugía uterina mayor
- **Desproporción fetopélvica**
- **Sufrimiento fetal preexistente**, sospecha o evidencia clínica
- Antecedentes de **parto difícil o traumático**
- ≥ 6 embarazos a término (**mujeres múltiples**)
- Presentación del feto transversa
- **Urgencias obstétricas** (cirugía recomendada)
- Secreción vaginal inexplicable o sangrado uterino anormal **durante el embarazo actual**



ADVERTENCIAS

En ausencia de estudios específicos, **no se recomienda el uso de Misoprostol** en pacientes que sufran:



Insuficiencia renal



Insuficiencia hepática



Desnutrición



Antes y durante el uso del medicamento, la actividad uterina, el estado fetal y las características del cuello uterino (dilatación y borramiento) **deben controlarse cuidadosamente**, mediante la auscultación o la monitorización fetal electrónica.

ADVERTENCIAS

En el caso de que las pacientes desarrollaran hipercontractilidad o hipertonía uterina, o si la frecuencia cardíaca del feto **no fuera normal**, **deben tomarse medidas para minimizar los riesgos para la madre y el feto.**

PRESENTACIÓN



FORMA FARMACÉUTICA

Comprimidos vaginales de forma redondeada y blancos con una ranura en un lado y de 9 mm de diámetro.



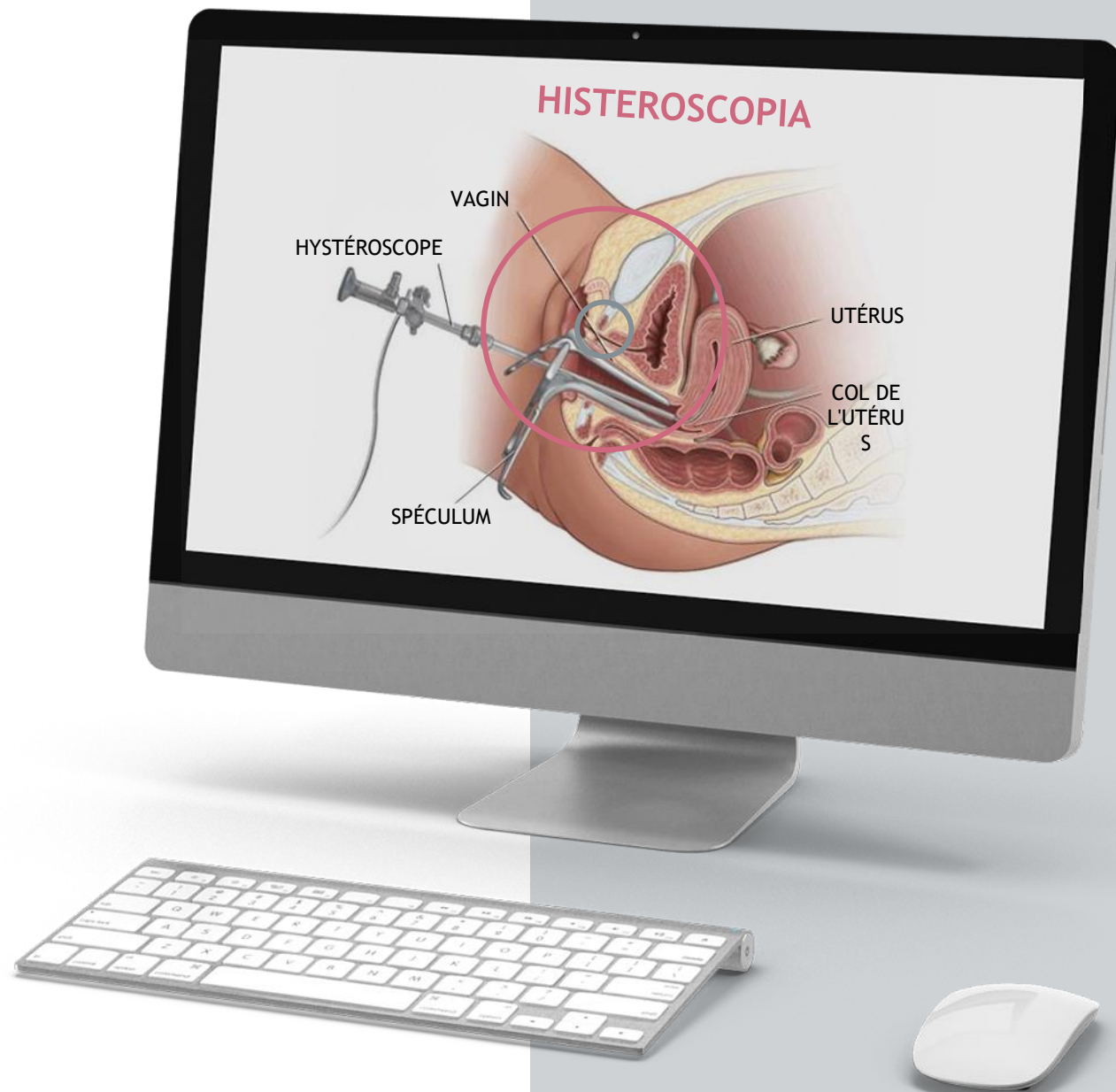
PRESENTACIÓN

Caja de 8 comprimidos en blíster de aluminio. Período de validez de 36 meses. **No requiere condiciones especiales de conservación.**



PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS **MISOPROSTOL 200**

PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS



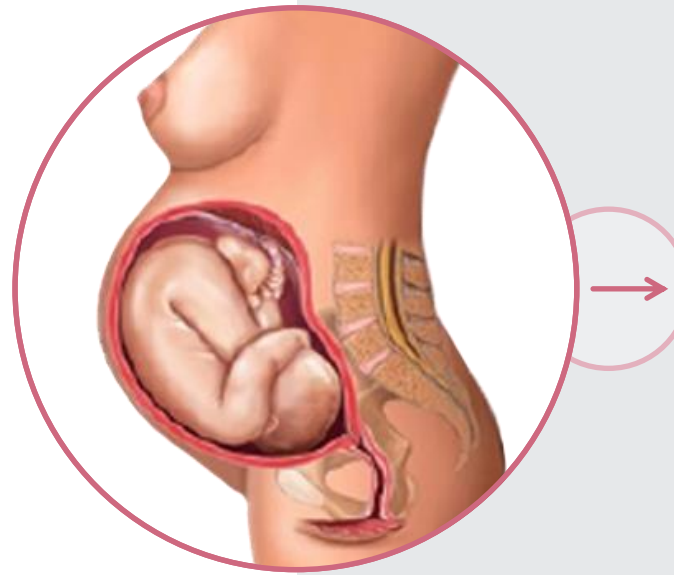
MISOPROSTOL 200 µg

MECANISMO DE ACCIÓN

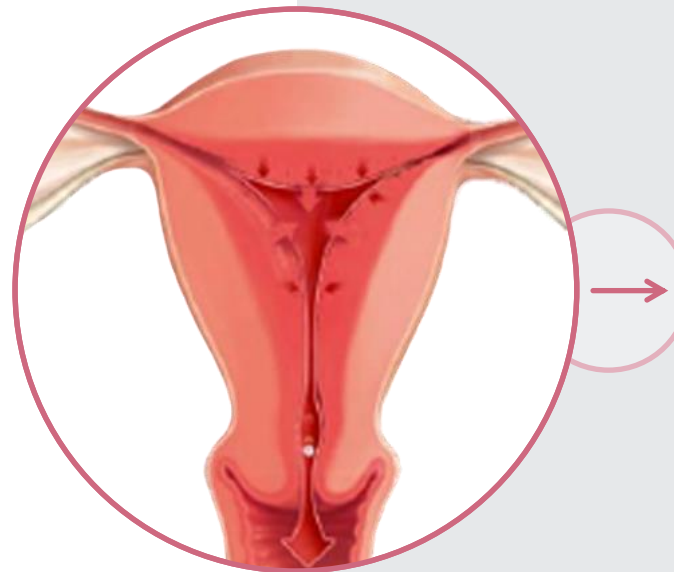
El mecanismo de acción es el mismo que con Misoprostol 25¹ pero la dosis es diferente (200 µg)².

¿POR QUÉ?

El útero de la mujer al final del embarazo es muy diferente de un útero que no alberga un feto (útero no gestante), como es el caso de las mujeres que van a someterse a una **histeroscopia** diagnóstica o quirúrgica.²



En el útero de una mujer embarazada, los receptores de oxitocina están activos y son más numerosos.



En los úteros no gestantes, los receptores de oxitocina son menos numerosos, por lo que se necesita una mayor cantidad de misoprostol para lograr la dilatación.



EFICACIA Y SEGURIDAD **HYSTEROSCOPIA**

LA PRINCIPAL CAUSA DE QUE NO SE PUEDA HACER
LA HISTEROSCOPIA ES EL
DOLOR.

Un estudio sobre la aceptabilidad y el dolor durante una histeroscopia indicó que el procedimiento es doloroso incluso cuando lo realiza un cirujano experimentado que utiliza una técnica no traumática. **El dolor influye negativamente en la cooperación de las pacientes, así como su disposición a someterse a otros tratamientos similares. En muchas histeroscopias, el cuello uterino debe dilatarse.**

¡REASON WHY!

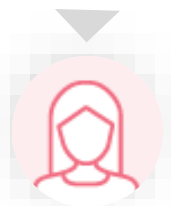
De Iaco P et al., Acceptability and pain of outpatient hysteroscopy;
J Am Assoc Gynecol Laparosc. 2000 Feb; 7(1):71-5



DILATADORES DE
HEGAR

DOLOR

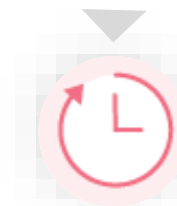
FACTORES RELACIONADOS CON UN DOLOR INTENSO E INTOLERABLE



Nuliparidad



Patología del
cuello del útero



Duración de la
intervención
>2 minutos

ESCALA DE DOLOR EVA*

01

42,1
CON
MISOPROSTOL

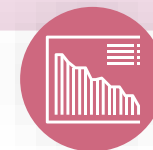
vs.

02

57,2
CON PLACEBO



↓
El dolor registrado
tras la dilatación
fue significativamente
menor en el grupo
de misoprostol que
en el grupo
placebo.



**MISOPROSTOL 200 µg
DISMINUYE EL DOLOR
SENTIDO DURANTE LA
HISTEROSCOPIA**

*EVA - escala visual analógica P<0,004 | Misoprostol n=50 | Placebo n=51

Referencia: Waddell G, Desindes S, Takser L, Beauchemin MC, Bessette P. Cervical ripening using vaginal misoprostol before hysteroscopy: a double-blind randomized trial. J. Minim. Invasive. Gynecol. 2008;15(6):739-44.

DOSIS

Y ADMINISTRACIÓN



DOSIS RECOMENDADA

400 µg
Misoprostol

En mujeres **sin**
antecedentes de
cesárea o útero
cicatricial

2-8
horas
antes

2-4
horas
antes

En mujeres **con**
antecedentes
de cesárea o
útero
cicatricial



Extraiga el comprimido vaginal de su blíster.



La **paciente debe** recostarse sobre la espalda, con las rodillas subidas hacia el pecho.



El **comprimido vaginal** debe introducirse sirviéndose del extremo del dedo medio.



La **dosis recomendada** es de 400 microgramos 2 a 8 horas antes del procedimiento en mujeres sin antecedentes de cesárea o útero cicatricial y 2 a 4 horas antes en mujeres con antecedentes de cesárea o útero cicatricial.

PRESENTACIÓN



FORMA FARMACÉUTICA

Comprimidos vaginales: blancos, oblongos, ranurados, de 14 x 6 mm.¹

PRODUCTO HOSPITALARIO



PRESENTACIÓN

Caja de 4 comprimidos en blíster de aluminio. Período de validez de 36 meses. **No requiere condiciones especiales de conservación.**¹

Referencias:

1: Misofar 200 SmPC.

Bial, 2022 - For exclusive internal use : for educational, general reference and informational purposes only, within the training context. Any unauthorized use, reproduction, distribution, recording or modification of these text and images is strictly

CONTRAINDICACIONES¹



Pacientes para las que los oxitócicos están contraindicados



Embarazo



Antecedentes de hipersensibilidad al misoprostol



Pacientes para quienes las contracciones prolongadas son inapropiadas



Referencias:

1: Misofar 200 SmPC.

Bial, 2022 - For exclusive internal use : for educational, general reference and informational purposes only, within the training context. Any unauthorized use, reproduction, distribution, recording or modification of these text and images is strictly



RECAPITULEMOS...

Un análisis global de los datos actuales nos muestra que el misoprostol se absorbe rápidamente cuando se administra por vía oral, vaginal, rectal o intracervical.

- Una dosis vía oral de misoprostol tarda **8 minutos en actuar** y la **duración de los efectos** es de aproximadamente **2 horas**.
- Una dosis sublingual de misoprostol tarda **11 minutos en actuar** y la **duración de los efectos** es de aproximadamente **3 horas**.
- Una dosis vaginal de misoprostol tarda **20 minutos en actuar** y la **duración de los efectos** es de aproximadamente **4 horas**.

Debido a la inexistencia de paso intestinal y hepático con la administración vaginal, parece que la actividad y la biodisponibilidad del misoprostol son superiores por **vía vaginal**.

Una mayor biodisponibilidad por vía vaginal provoca **contracciones uterinas más regulares y prolongadas**



RECAPITULEMOS...

La vía vaginal presenta **menos reacciones adversas**, como náuseas, vómitos y diarrea, tras la administración. También se considera más eficaz en la inducción del parto en mujeres nulíparas que presenten un cuello uterino desfavorable. Estos resultados son consistentes con los hallazgos de una revisión Cochrane que considera que el **misoprostol por vía vaginal es más efectivo que mediante administración oral** y tiene menos efectos secundarios que el misoprostol por vía oral o sublingual.

La vía vaginal parece ser más eficaz que la vía oral, lo que se traduce en un **intervalo más corto entre la inducción y el parto** y una **menor necesidad de aumento de la oxitocina**.

La vía vaginal también es más interesante porque **los picos se alcanzan más lentamente** y se **mantienen durante un período de tiempo más largo**, lo que se asocia con **menos efectos secundarios**.

IEC Misofar 25

Nombre comercial del medicamento: Misofar 25 microgramos comprimidos vaginales DCI (Denominaciones Comunes Internacionales) o nombres genéricos aprobados de la(s) sustancia(s) activa(s): Misoprostol **Composición cualitativa y cuantitativa:** Comprimidos vaginales de color blanco, forma redonda con ranura en cruz en una de las caras y de 9 mm de diámetro. Cada comprimido contiene 25 microgramos de misoprostol **Forma farmacéutica:** Comprimido vaginal **Indicaciones terapéuticas:** Maduración cervical e inducción del parto a término, especialmente en casos de cuello uterino inmaduro, siempre que no existan contraindicaciones fetales o maternas **Posología y forma de administración:** 25 microgramos de misoprostol a intervalos de 4-6 horas, hasta un máximo de 4 a 6 comprimidos **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al misoprostol, a las prostaglandinas o a alguno de los excipientes. Pacientes en las que los fármacos oxitócicos están contraindicados o con contracciones inapropiadas del útero. Historial de cesárea o cirugía mayor uterina. Desproporción cefalopélvica. Sospecha o evidencia de sufrimiento fetal. Historial de parto difícil y/o parto traumático. Múltiparas. Situaciones del feto transversas. En emergencias obstétricas, embarazo múltiple, secreción vaginal inexplicable y/o hemorragia uterina o que no esté indicado el parto por vía vaginal. Administración simultánea de oxitocina u otros estimulantes de las contracciones uterinas. Pacientes con factores de riesgo de presentar embolismo de líquido amniótico, preeclampsia grave o eclampsia **Reacciones adversas:** Más graves: hipersensibilidad al fármaco, rotura uterina y parada cardíaca. Más frecuentes: náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Ocasionales: reacciones de hipersensibilidad, síncope, neurosis, mareo, confusión, somnolencia, cefalea, temblores, ansiedad, trastornos en la visión y conjuntivitis, hipertensión, hipotensión, arritmia cardíaca, flebitis, edema, tromboembolismo, tos, disnea, bronquitis, neumonía, epistaxis, erupción cutánea, erupción exantemática, dermatitis, alopecia, artralgia, mialgia, calambres y agarrotamientos musculares, dolor de espalda, poliuria y hematuria, contractilidad uterina anormal con o sin bradicardia fetal, rotura uterina, rotura prematura de membranas, desprendimiento prematuro de placenta, amnionitis, embolismo pulmonar, hemorragia vaginal, dismenorrea y hemorragia vaginal, hipertermia transitoria, escalofríos. Alteración del ritmo cardíaco, acidosis, sufrimiento y/o sepsis fetal intrauterina, síndrome de aspiración de meconio y sufrimiento neonatal **Advertencias y precauciones especiales de empleo:** No se recomienda para pacientes con: insuficiencia renal, hepática o desnutrición. Observación de la dosis y posología recomendados. Utilizar únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia. Índices cefalopélvicos deberán medirse antes de la utilización. Debe controlarse la actividad uterina, el estado fetal, las características del cérvix y el riesgo de rotura del útero. Mayor riesgo de coagulación intravascular diseminada posparto en las pacientes en que se les ha inducido el parto mediante un método fisiológico o farmacológico. Atención a trastornos hemostáticos acompañados de hipocoagulabilidad o con anemia. Pacientes con: Epilepsia o antecedentes, enfermedad renal, hepática y/o cardiovascular **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** Puede potenciar el efecto de la oxitocina. Acenocumarol, Antiácidos, AINEs y Laxantes **Titular de la autorización de comercialización:** Laboratorios BIAL, S.A., C/ Alcalá 265, Edificio 2, Planta 2ª 28027 Madrid, España **Numero(s) de autorización de comercialización:** España: 69682; El Salvador: F009120022020; Honduras: HN-M-1019-0059. **Fecha de la primera autorización /Fecha de la revisión del texto:** España: 16 marzo 2008; El Salvador: 25 febrero 2020; Honduras: 22 octubre 2019 / Agosto 2020. **Disponibilidad del producto en el mercado:** Medicamento sujeto a prescripción médica. Deben comunicarse las reacciones adversas a las autoridades sanitarias del país siguiendo los procedimientos establecidos en dicho país o utilizando el correo electrónico de farmacovigilancia: pharmacovigilance@bial.com. Para más información, contacte con el titular de la autorización de comercialización. Para obtener información detallada, consulte el resumen completo de las características del producto.

IEC Misofar 200

Resumen abreviado de las características del producto

Nombre comercial del medicamento: Misofar 200 microgramos comprimidos vaginales. **DCI (Denominaciones Comunes Internacionales) o nombres genéricos aprobados de la(s) sustancia(s) activa(s):** Misoprostol **Composición cualitativa y cuantitativa:** Los comprimidos vaginales de color blanco, forma capsular oblonga con ranura y de 14x6 mm de dimensión **Forma farmacéutica:** Comprimido vaginal **Indicaciones terapéuticas:** Dilatación del cérvix de útero no grávido previa a una histeroscopia u otros procedimientos ginecológicos que requieran acceder a la cavidad uterina **Posología y forma de administración:** La dosis recomendada es de 400 microgramos de misoprostol de 2 a 8 horas antes en úteros sin historial de cesárea previa o cicatrices uterinas, y de 2 a 4 horas antes en úteros con historial de cesárea previa o cicatrices uterinas **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al misoprostol, a las prostaglandinas o a alguno de los excipientes. Pacientes en las que los fármacos oxitócicos están generalmente contraindicados o en las que las contracciones prolongadas del útero se consideren inapropiadas. Embarazo o sospecha de embarazo **Reacciones adversas:** Más graves: hipersensibilidad al fármaco, rotura uterina y parada cardíaca. Reacciones adversas más frecuentes: náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Efectos adversos ocasionales: reacciones de hipersensibilidad, síncope, neurosis, mareo, confusión, somnolencia, cefalea, temblores, ansiedad, trastornos en la visión y conjuntivitis, hipertensión, hipotensión, arritmia cardíaca, flebitis, edema, tromboembolismo, tos, disnea, bronquitis, neumonía, epistaxis, trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: erupción cutánea, erupción exantemática, dermatitis, alopecia, artralgia, mialgia, calambres y agarrotamientos musculares, dolor de espalda, poliuria y hematuria, contractilidad uterina anormal con o sin bradicardia fetal, rotura uterina, rotura prematura de membranas, desprendimiento prematuro de placenta, amnionitis, embolismo pulmonar por líquido amniótico, hemorragia vaginal, dismenorrea y hemorragia vaginal, hipertermia transitoria, escalofríos **Advertencias y precauciones especiales de empleo:** no se recomienda en pacientes con: insuficiencia renal, insuficiencia hepática, desnutrición. Precaución en pacientes con: epilepsia o antecedentes, en pacientes con insuficiencia renal y/o hepática moderada o grave. No se recomienda su uso en estos casos; enfermedad cardiovascular, hipotensión, historial de cesárea o cirugía mayor uterina. Especial atención a las pacientes con trastornos hemostáticos acompañados de hipocoagulabilidad o con anemia. Mayor riesgo de coagulación intravascular diseminada posparto en las pacientes en las que se les ha inducido el parto mediante un método fisiológico o farmacológico. Puede causar reacciones en la piel **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción** Acenocumarol, Antiácidos, AINEs, Laxantes [○] **Titular de la autorización de comercialización:** Laboratorios BIAL, S.A., C/ Alcalá 265, Edificio 2, Planta 2ª 28027 Madrid, España **Numero(s) de autorización de comercialización:** España: 69683; El Salvador: F06202112019; Honduras: HN-M-1019-0060. **Fecha de la primera autorización /Fecha de la revisión del texto:** España: 16 marzo 2008; El Salvador: 29 noviembre 2019; Honduras: 22 octubre 2019 / Agosto 2020. **Disponibilidad del producto en el mercado:** Medicamento sujeto a prescripción médica. Deben comunicarse las reacciones adversas a las autoridades sanitarias del país siguiendo los procedimientos establecidos en dicho país o utilizando el correo electrónico de farmacovigilancia: pharmacovigilance@bial.com. Para más información, contacte con el titular de la autorización de comercialización. Para obtener información detallada, consulte el resumen completo de las características del producto.

*Muchas gracias
por su atención*

